Bloqueos de conducción y bradicardia

FISIOPATOLOGIA · Clase 17 · dónde se frena el impulso: del nódulo sinusal al haz de His y qué pasa cuando el corazón late muy lento

1 · DÓNDE SE FRENA EL IMPULSO

F21
Infarto inferior
el NAV depende 90 % de la coronaria derecha y se isquemia; el bloqueo suele ser transitorio

F2
Causas del bloqueo
cardiopatía chagásica (primera causa), miocardioesclerosis del anciano, infarto y fármacos (digitálicos, betabloqueadores, bloqueadores de calcio)

Vago hiperactivo
frena el sinusal y el NAV

frena el impulso a la salida del
lo retrasa o bloquea en el
bloquea una rama del
retrasa la conducción en el

F20
Bloqueo sinoauricular
el impulso no sale del nódulo sinusal: pausa sin P ni QRS en el ECG

Bloqueo AV
el impulso se retrasa o no pasa a nivel del nódulo auriculoventricular

Haz de His y ramas
bloqueo debajo del NAV (infranodal)

retrasa la conducción y da
si solo hay retraso fijo, da
si el bloqueo es bajo, da
si ningún impulso pasa, da

2 · BLOQUEOS AV LEVES: 1.º Y MOBITZ I

F3 · F24
BAV de 1.er grado
PR mayor de 0,20 s y fijo; todas las P conducen (relación 1:1)

al alejar las sístoles, debilita el

F3
Primer ruido disminuido
con el PR largo las válvulas AV cierran con menos fuerza

F4 · F21
Mobitz I (Wenckebach)
el PR crece latido a latido hasta que una P no pasa; nodal, benigno

casi nunca progresa y queda
es el único hallazgo y el cuadro queda

si el retraso crece, da

Casi siempre asintomático: se vigila y se ajusta el fármaco

3 · BLOQUEOS AV GRAVES: MOBITZ II Y COMPLETO

F5
Mobitz II
PR fijo y una P cae sin aviso (2 o 3 P por QRS); infranodal, ventrículos a 40-60 lpm

con pausas largas puede dar
al ser infranodal puede progresar a

F6 · F7
BAV completo (3.er grado)
P y QRS disociados, PR variable, más P que QRS; escape ventricular a 30-40 lpm con QRS ancho (aurículas a ~80)

con ventrículos a 30-40 lpm da

si es por fármaco, se resuelve con

F1 · F9
Síndrome de Stokes-Adams
FC menor de 40: síncope, convulsiones y cianosis por falta de flujo al cerebro

si se prolonga termina en

se previene con el

Paro cardiaco: reanimación (RCP) hasta colocar el marcapaso

si da síntomas se trata con

5 · FIBRILACIÓN AURICULAR

también favorece la

F13
Fibrilación auricular
aurículas a 400-600 lpm, sin onda P y QRS irregularmente irregular

al perder la contracción auricular causa

F13
Se pierde la contracción auricular
cae el llenado ventricular (20-30 %) y baja el gasto

al estancar la sangre favorece

F13
Trombos en la aurícula
complicación principal; primera causa de FA: la estenosis mitral

si se desprende, produce

Tromboembolismo: el trombo viaja y produce ACV embólico

6 · BRADICARDIA SINUSAL

enlentece el nódulo sinusal y da

F15
Causas de la bradicardia
sueño, deportistas, fármacos, hipotiroidismo y ictericia obstructiva (las sales biliares impregnan el sinusal)

por tono vagal exagerado produce

F14 · F17
Bradicardia sinusal
FC menor de 60 lpm con una P antes de cada QRS, PR cerca de 0,20 s y R-R regular; vago exagerado

si el bloqueo es alto, indica

en el deportista sano es

F22
Deportista asintomático
45-50 lpm es normal para él y no se trata

no debe confundirse con la

F19
Arritmia sinusal
la FC sube al inspirar y baja al espirar; fisiológica, desaparece con el ejercicio

como no hay síntomas, queda sin
por ser benigna queda sin

4 · BLOQUEOS DE RAMA DEL HIS

si falla una rama, da

F10
Bloqueo de rama
el QRS dura 0,12 s o más (completo); menos de 0,12 s es incompleto

si es la rama derecha, da
si es la rama izquierda, da

F10
BCRD
rSR' en V1 y S ancha en V6; tras el tabique se activa el VI y luego el VD; típico del Chagas

F11
BCRI
R ancha en V6; tras el tabique se activa el VD y luego el VI; cardiopatía isquémica

no tiene tratamiento y se vigila con
se vigila porque puede progresar con

Sin tratamiento específico: monitorizar con ECG

con FC menor de 40 puede dar

7 · TRATAMIENTO: ATROPINA Y MARCAPASO

con lipotimia o síncope se da

No requiere tratamiento: deportista y arritmia sinusal

Si la causa es un fármaco: suspender o ajustar la dosis

F16 · F18
Atropina
bloquea el efecto vagal sobre el nódulo sinusal y sube la FC; se da si hay lipotimia o síncope

si no basta o hay Stokes-Adams, pasa al

F8 · F23
Marcapaso: transitorio en el infarto o por fármacos; definitivo en el Chagas y la miocardioesclerosis

causa · concepto · mecanismo · signo · desenlace · complicación · diagnóstico · ejemplo · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.º # de la lámina

Fuente: Clases 22 y 23 · Dr. Sotito — teoría del docente (= literatura)